



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متدد

إسم المريض رباعياً : سهير زكى سيد زكى
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الهرم
رقم البطاقة : 25209052502102 رقم التليفون : 01224334884
العنوان : ...
العمر (تاريخ الميلاد) : 05-09-1952 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة
قسم العلاج :
الأورام [11129]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سهير زكي سيد زكي National ID: 25209052502102	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


 جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية
 مهنير
 زكى محمد
 ١٦ من بورسعيد، تقسيم احمد ابو طالب
 الهرم - الجيزة
 ١٩٥٢/٠٩
 ٢٥٢.٩.٥٢٥.٢١.٢
 LA8198748

١١٩٨٩
 ١٢٩٤٢٢٤٨٨٤
 ع
 ٩٨٠

٢٠٢٥/٠٣ ٢٥٢.٩.٥٢٥.٢١.٢
 يعون عمل
 انقى
 مسيحية
 ارملة
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/٠٣/٠٩


9

Patient Name: soheir zaky.

Date: 31 /8/2026

BILATERAL SONOGRAPHY

- Normal fibro-glandular parenchyma is seen, (ACR-C).
- The left breast shows retro-areolar medium density mass with partially defined partially obscured margins.
- No suspicious clustered micro-calcification is seen.
- Normal skin thickness, subcutaneous fat and nipple areolar complex.

COMPLEMENTARY BREAST ULTRASOUND:-.

- Bilateral breasts are of heterogeneous parenchymal texture, mostly glandular.
- The right breast shows ill defined hypo-echoic solid mass with macrolobulated margin, seen at the retro-areolar region showing heterogeneous texture with anechoic areas of cystic changes and hyper echoic areas as well. The lesion is measuring about 4.7x3.5x2.0 cm in dimensions. By Doppler study it shows internal vascularity. By Micropure technique its shows calcifications.
- No dilated lactiferous ducts.
- Normal skin thickness & subcutaneous fat lobules
- Both axillae show enlarged LNs with preserved echogenic fatty hilum.

OPINION:

- Right breast suspicious looking lesion as described.
Histopathological assessment is recommended. (BIRADS IV a)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والحمد لله رب العالمين

MUCH Obliged.

DR. walaa ahmed, MSc.
B.S. radiology M8

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الادارة المركزية لتنظم المعلومات و التحول
الرقمي

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار: 2026-9-9

جهة الاصدار: فرع الجيزة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) سهير زكى سيد بطاقة رقم 25209052502102
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة: 2026-9-9

الموظف المختص

احمد ياسر

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،



مسلسل 2073712



الخطاب ماري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو
وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الادارة المركزية لتنظم المعلومات و التحول الرقمي





Handwritten notes in Urdu at the top right of the page.

DR. walaa ahmed, MSc.
MUGA Obayed.

- Right breast suspicious looking lesion as described. (BIRADS IV a)

OPINION:

- Bilateral breasts are of heterogeneous parenchymal texture, mostly glandular.
- The right breast shows ill defined hypo-echoic solid mass with macrolobulated margin, seen at the retro-areolar region showing heterogeneous texture with anechoic areas of cystic changes and hyper echoic areas as well. The lesion is measuring about 4.7x3.5x2.0 cm in dimensions. By Doppler study it shows internal vascularity. By Micropure technique it shows calcifications.
- No dilated lactiferous ducts.
- Normal skin thickness & subcutaneous fat lobules
- Both axillae show enlarged LNs with preserved echogenic fatty hilum.

COMPLEMENTARY BREAST ULTRASOUND:-

- Normal fibro-glandular parenchyma is seen, (ACR-C).
- The left breast shows retro-areolar medium density mass with partially defined partially obscured margins.
- No suspicious clustered micro-calcification is seen.
- Normal skin thickness, subcutaneous fat and nipple areolar complex.

BILATERAL SONOGRAPHY

Patient Name: soheir zaky.
Date: 31/8/2026

Handwritten number 3 in a circle at the bottom center.

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: سحر زكي سيد	Age: 74 years	Sex: female
Request type: ميلار ه	Sub request type:	
Hospital no:	Pathology no.: 971B-2026	
Department: صدره	Date of result: 19/9/2026	
Referred by: د/هداية نور	Date of biopsy: 10/9/2026	
Nature of specimen: tru-cut biopsy	I.D. Number: 25209052502102	
Clinical diagnosis: Right breast mass		

Gross pathology:

multiple gray white cores up to 1cm long each, totally submitted

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: Ecadherine-ER-PR-Her2-Ki67.

Microscopic picture:

Sections examined revealed breast tissue core showing malignant growth. Tumor forms files, single dyscohesive cells, infiltrating among fibrotic stroma. Tumor cells showed moderate anaplasia with mild tendency to form tubules.

Immunohistochemical Result:

ER: Strong nuclear staining in 60% of tumor cells (Allred Score 7/8).

PR: Moderate nuclear staining of 40% of the tumor cells (6/8).

Her2: Weak incomplete membranous staining in >10 % of tumor cells (Score 1+)Low.

Ki67: Positive nuclear staining of 20% of tumor cells

Diagnosis: Right breast mass, tru-cut biopsy:

Provisional Mammmary Core biopsy of Invasive lobular Carcinoma (NST), Grade II, for clinical and radiologic correlation.

Signature:

Dr.Mona Mohamed.M.D

Patient Name: soheir zaky.
Date: 31/8/2026

BILATERAL SONOGRAPHY

- Normal fibro-glandular parenchyma is seen, (ACR-C).
- The left breast shows retro-areolar medium density mass with partially defined partially obscured margins.
- No suspicious clustered micro-calcification is seen.
- Normal skin thickness, subcutaneous fat and nipple areolar complex.

COMPLEMENTARY BREAST ULTRASOUND:-

- Bilateral breasts are of heterogeneous parenchymal texture, mostly glandular.
- The right breast shows ill defined hypo-echoic solid mass with macrolobulated margin, seen at the ~~retro-areolar~~ region showing heterogeneous texture with anechoic areas of cystic changes and hyper echoic areas as well. The lesion is measuring about 4.7x3.5x2.0 cm in dimensions. By Doppler study it shows internal vascularity. By Micropure technique it shows calcifications.
- No dilated lactiferous ducts.
- Normal skin thickness & subcutaneous fat lobules
- Both axillae show enlarged LNs with preserved echogenic fatty hilum.

OPINION:

- Right breast suspicious looking lesion as described.
- Histopathological assessment is recommended. (BIRADS IV)

DR. wafaa ahmed, MSc.
MRCGP Obligated,
D. C. Mahany M.

المرضى
الذين
يحتاجون
إلى
فحص
الثدي
بالتصوير
الموجي
اللون
والدوبلر
والتي
تظهر
كتلة
صلبة
في
المنطقة
التي
تحت
الثدي
اليمين
وتظهر
تغيرات
نسيجية
مختلفة
مع
تغيرات
كيسية
ومناطق
عكسية
عالية
كما
تظهر
تغيرات
في
البنية
النسجية
للثدي
وتظهر
تغيرات
في
البنية
النسجية
للثدي

8-9
R. g. k. f.

9